

서형 관경 코멘트



환자분께 전달해야 할 구체적인 정보가 방 안에 있기 때문에 빠른 시간 안에 해당 내용을 파악하는 것이 필요하겠습니다.

환자분을 위로해야 하는 타이밍이 상담 동안 몇 번 존재할 것입니다. 이때를 대비해 **본인만의 위로할 수 있는 멘트**를 3개 이상 마음에 품고 가는 것이 좋습니다.

나쁜 소식 전하기는 환자에게 향후 치료를 통해 조금이라도 희망적인 부분을 알려 줄 수 있는 케이스가 있지만 희망적인 부분이 없는 경우 많은 학생들이 어려워 할 수 있습니다.

환자는 부정/분노/타협/우울/수용의 과정을 모두 보여 줄 가능성이 높고, 환자에게 끊임없이 위로의 말을 건네기 보다는 때로는 **환자에게 생각할 시간을 주며 침묵으로 기다리는 것도 방법**일 수 있습니다. 마지막으로 **환자에게 가장 걱정되는 부분**이 무엇인지 묻고 **이에 대한 조치**를 마련해 줄 수 있도록 마무리하는 방법도 좋은 흐름입니다.

나쁜 소식 전하기는 환자가 정보를 받아들이는 과정에서 기다려 주고, 공감, 이해, 격려해 주는 것이 핵심입니다. 따라서 어려운 의학 용어를 사용해야 할 경우 **쉬운 용어로 한번 더 풀어주며**, 이해가 안 된 부분은 없는지 확인하도록 합니다.

환자의 죽음에 대해 너무 격하게 공감하여 정보 전달을 제대로 못하거나, 감정적인 부분을 공감하는 표현없이 객관적으로 정보 전달만 하는 실수를 하지 않도록 주의하세요.

상담 상황

계통	상황	질병 설명	진단/치료 계획 설명
암 (치료 가능)	유방암 1기 진단	Mammography, Sonography 소견서를 읽어가면서 설명 조직검사 잘못된 것 아닌지, 유방암 가족력 없는데 웬말이냐며 부정의 모습을 보이는데, 조직검사 소견이 정확하다고 하면 잘 수용함	유방암 1기의 경우 5년 생존률이 100%에 가깝기 때문에 적절한 치료를 받으면 완치도 가능함 유방보존절제술 : 유방을 모두 절제하는 경우는 드물며, 유방을 보존하고 종괴만 절제한 뒤 방사선 치료를 할 것이다. 수술하면 5~7일 정도 입원할 것임

암 (치료 가능)	위암 2기 진단	위궤양 정도로 생각하고 있으나 위암으로 나와서 당황하고 분노 예전에 아버지가 폐암으로 항암 치료 받으면서 아버지, 가족들 다 고생했었다면서 자기 항암 치료 받기 싫다고 함	위암은 다른 암에 비해서 생존률이 높으며, 위전절제술을 받으면 대부분 완치됨 위암 2기는 항암 치료를 할 수도 있고 안 할 수도 있는데, 하게 되면 예전보다 좋은 항암제가 나오기도 했고 분화도가 좋은 경우에는 반응도 좋을 것이므로 안심해도 됨
	소아암 진단	소아가 백혈병이 진단되어 어머니가 죄책감을 가지고 있음 처음엔 믿지 못하겠다는 표정으로 “정말이요? 맞아요? 아직까지 한 번도 안 아팠던 아이예요”라고 하다가 맞다고 하면 우울한 모습 보이고, 수용 현재 경제적으로 문제는 없지만 앞으로 문제가 될 것 같다고 하심 일 년 후에 학교 가야하는지도 질문	신체적인 문제에 대해서는 정확한 혈구 수치들이 주어짐 항암 치료 계획과 함께 앞으로 생길 수 있는 문제들 설명 백혈병 환자 재단 말씀드리고, 항암제의 필요성 및 부작용 설명 집은 주변에 있어서 치료를 받을 수 있다고 하심 어머니가 힘내시는 게 중요하다고 말씀드렸더니 괜찮아지는 모습
암 (치료 불가)	췌장암 4기 진단	췌장암으로 진단받고 수술이 불가능하여 항암 치료 4cycle을 받은 상태 CT 결과 췌장암의 크기는 증가하였고, 이전에 없던 췌장 주변 림프절 비대가 보였으며, 간으로도 3cm 내외의 여러 개의 종괴들이 보이는 상황(전이) 5년 생존률 : 2% 기대 여명 : 3개월	완화 치료 : 통증 완화, 방사선 치료 호스피스 : 임종이 임박한 환자들이 편안하고도 인간답게 죽음을 맞을 수 있도록 위안과 안락을 제공하는 곳, 삶의 마지막 순간을 평안하게 맞이 할 수 있도록 하며, 사별 후 가족이 갖는 고통과 슬픔을 잘 극복할 수 있도록 돕는 총체적인 돌봄을 제공하는 치료
에이즈 진단	HIV(+)	Western blot 양성이라고 결과가 나왔으나 이에 대해 부정하고 다시 검사하고 싶다고 함 → 이것은 거의 확실한 검사이므로 다시 해도 결과는 비슷할 것이라고 설명 에이즈는 면역 약화가 되는 질병으로 면역 약화 시 걸릴 수 있는 질병에 대한 치료가 중요	항 HIV 치료제 보통 세 가지 종류의 약을 동시에 사용하는 소위 콕테일 요법을 사용하게 되며, 현재로서는 항 HIV 약제는 평생 동안 먹어야 함, 만성병처럼 계속 관리하는 질병 아이에 전염될 수 있으니 아이를 비롯한 가족에 대해서도 검사를 꼭 해야 함, 설명이 어려운 경우에 가족을 데리고 오면 대신 설명을 해줄 수 있다고 언급

반응 5단계	설명
부정	죽는다는 사실을 받아들이기 어렵다. 현실이나 그런 상황을 외면하려고 한다. 막연히 회복을 꿈꾼다.
분노	“왜 나야?”, “너무 불공평하다” 등 분노를 감추지 못한다. 자신과 주변을 돌보지 않는다. 건강한 사람에 대한 질투와 가까운 이웃에게 화를 낸다.
타협	몇 년만 더 살게 해달라고 애원한다. 열심히 기도하고 기적을 바란다. 신과 대 타협을 하려고 한다. “살려만 주신다면...”
우울	환자의 증상이 더 뚜렷하게 되고 기력이 쇠하면서 죽음을 직시하게 된다. 상실감이 깊어지면서 말이 없고, 사람의 접촉도 피하게 된다. 슬픔, 후회, 공포를 느낀다.
수용	마음을 비우는 단계다. 더 이상 세상에 미련을 두지 않는다. 분노와 우울이 사라진다. 환자와 가족들이 지쳐 있다. 서서히 죽음을 받아들인다.

상담 플로우

* SPIKES(Setting-Perception-Invitation-Knowledge-Emotion-Strategy/Summary)

Setting (안정된 환경과 분위기 제공)	〈환자가 들을 준비가 되었는지 확인〉 [자기 소개] 안녕하세요? 이00씨, 그 동안 잘 지내셨나요?/저는 학생의사 박00입니다. [보호자 동반 여부] 보호자와 같이 오셨나요?/아니면 혼자 오셨나요? [존중과 관심 표현] 오늘 기분은 어떠세요?/그 동안 불편하셨던 것은 없었나요?/원래 아프시던 부위는 요새 어떠신가요?
Perception	〈환자의 병식 확인〉 [검사했던 것 다시 주지] 지난 번에 어떤 증상 때문에 검사하셨고, 그 날 조직검사도 시행했던 것 기억하시나요? [결과에 대한 환자의 느낌] 결과가 어떠실 것 같으신가요? [본인 상태] 결과를 설명드리기 전에 본인의 상태에 대해서 얼마나 알고 계신지 여쭙어 봐도 될까요?
Invitation	〈환자가 얼마나 알고 싶어하는지 확인/면담 참여〉 [심각성] 결과를 말씀드리려고 하는데요, 저희가 기대하던 결과와는 조금 다른 결과가 나와서 의논을 하려고 합니다. 괜찮으신가요? [어디까지 들을건지] 오늘 진단 결과만 말씀드릴까요?/아니면 치료 방법까지 논의하시겠습니까? [누구랑 들을건지] 혼자 들으셔도 되고 보호자 분과 같이 들으셔도 됩니다. 어떻게 하시겠습니까?

Knowledge	<정보 공유 및 설명> [진단명 알리기] 결과가 좋지 않습니다만, 우선 희망적인 부분도 많다는 것을 먼저 말씀드립니다. 유감스럽지만 환자분 진단명은 ○○○입니다(시간 주기 : 환자가 감정을 추스릴 시간을 주고, 울면 휴지도 건네준다). [위로] 많이 놀라셨을 것이라 생각합니다. 진단 나온 것에 대해서 설명을 해 드리려고 하는데 괜찮으실까요? [검사 결과 설명] 질병 자체에 대한 설명(천천히) * 한번에 적은 양의 정보를 주며, 주기적으로 요약하고, 필요하다면 반복적 설명 * 모르는 것 같으면 이해 안 되는 부분을 좀 더 이해하기 쉽게 설명 (이해가 되셨나요?/필요하다면 다시 설명해 드리겠습니다) * 검사결과지를 보면서 설명
Emotion	<환자 감정 탐색 및 감정에 적절히 반응> [걱정 묻기] 어떤 것들이 걱정되시나요? <침묵이 지속되는 경우 묻기> [위로 및 추가 정보 제공 동의] 많이 걱정되시겠지만, 다음 치료 계획에 대해서 함께 충분히 이야기하는 것도 중요하다고 생각합니다. *환자 “오진 아닌가요?” : 요즘 내시경을 통한 조직검사의 위암 진단은 진단률과 정확도가 매우 높습니다. 저희도 정확한 진단을 위해 최선을 다 했고, 이런 말씀을 드리기 힘들어서 몇 번 확인하였지만, 유감스럽게도 환자분은 위암이 맞습니다.
Strategy	<향후 계획> [추가 검사] 치료 계획을 세우려면 추가 검사가 필요합니다. 추가 검사 결과에 따라서 항암 치료, 수술을 할 수 있습니다. *모르는 것 같으면 이해 안 되는 부분을 좀 더 이해하기 쉽게 설명 → 지금까지 이해가 어려운 부분이 있을까요?
면담 끝내기	[위로 및 격려] 포기하지 마시고 힘내셨으면 합니다. 저를 포함해서 의료진들이 최선을 다해 도와드리겠습니다. [보호자에 대한 알림] 가족이나 보호자에게 말씀드리기 곤란하시면 제가 도와드리겠습니다. [위로 및 반복, 다음 약속잡기] 제가 필요하면 언제든지 도움이 되어 드리겠습니다. 제가 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 암기법 추위보약 설명 예전에는 추우면 보약 달여서 먹었었죠!



keyword

Setting : 분위기 조성

Perception : 병식 확인

Invitation : 누구랑, 얼마나 알고 싶어하는지 확인

Knowledge : 핵심만을, 이해하기 쉽게 전달, 유감 포함

Emotion : 공감, 시간 주기

Strategy : 이해 확인, 향후 계획

❖ AIDS 환자에게 설명할 치료 계획 및 지지적 면담 사항

- ① HIV(+)와 에이즈는 다르다.
- ② 면역체계 유지를 위한 치료(항레트로바이러스제)
- ③ 기회 감염의 위험에 대한 교육 : 생활 습관 변경을 통해 기회 감염을 줄여야 한다.
- ④ 안전한 성관계(콘돔 사용) 교육

❖ HIV 감염

- ① 정의 : HIV 감염으로 인해 면역 기능 저하가 오고, 기회 감염이 합병되는 질환
- ② 전파 경로 : 성매개 전파(70~80%), 주산기 감염(10~20%), needle stick injury
- ③ 진단 : ELISA(screening test)/Western blot(확진) : p25, gp120/160 중 2개 이상 검출되면 양성
- ④ 치료 : zidovudine + lamivudine combi, 4주간
- ⑤ F/U : HIV-RNA, CD4+ T-cell

❖ 암 환자에게 필요한 교육 계획

- ① 수술적 치료의 필요성, 수술의 부작용, 수술 후 관리, 생활 습관 개선 필요
- ② 환자와 가족에 대한 정신심리적 지지 및 생활 습관(식이, 금주, 금연) 교육
- ③ 암은 더 이상 불치의 병이 아니며, 병기에 따른 적절한 치료를 받으면 완치될 수 있음

❖ 위암

Stage	5YRS	Tx
I	50%	Curative resection이 원칙
II	30%	암 위치에 따라 subtotal/total gastrectomy 시행
III	10~15%	Post-op CTx : 생존률 증가
IV	3%	Post-op Cx { dumping synd. Afferent loop synd. Bile reflux Palliative : stent insertion, nutrition support

❖ 간암

①

Stage	5YRS
I	33%
II~III	11%
IV	2%

② Size와 child pugh class에 따라 수술 방법 달라짐

- 5cm 이하 1개 + Child A : 수술적 제거
- 5cm 이하 여러 개 + Child B, C : TACE
- Early HCC, 원격전이(+) : 간이식 가능

③ 수술적 절제, TACE, PEI, RFA, 간이식 (Child C에서)

❖ 결장/직장암

Stage	5YRS	Tx : curative resection
I	>90%	수술적 절제
II~III	71%	수술 or 항암 치료
IV	14%	고식적 치료

❖ 자궁경부암

Stage	5YRS	Tx
O	100%	자궁 절제
I	92%	자궁 절제
II	56%	자궁 절제 or CCRT
III	33%	Concurrent chemoRTx
IV	17%	CCRT

❖ 유방암

Stage	5YRS	Tx : 수술적 절제가 가능
I	99%	수술적 절제 Radical mastectomy, MRM, BCS 보조적 치료 Post-op CTx, post-op RTx, hormone therapy
II	86%	
III	55~70% (III C는 모름)	
IV	27%	

❖ 호스피스

- ① 의사 2인이 기대 여명을 6개월 미만으로 인정한 환자, 통증 조절이 목적
- ② 호스피스 기관의 운영 형태
 - 병원형 : 병원 내 호스피스 병동 or 일반 병동에 입원해 24시간 가족과 호스피스 팀이 서비스, 가족과 환자 모두가 안정을 찾도록 돕는다. 급성기 이후에는 집이나 장기요양시설로 옮겨야 하고, 병원이라 집처럼 편하지 않을 수 있다.
 - 독립형 : 입원 공간 없이 호스피스팀이 가정으로 방문, 비용경제적, 위기 상황에서 즉시 대처 어려울 수 있다.
 - 독립 시설형 : 호스피스 병동만으로 구성된 독립기관, 규모가 작아 증상 관리를 위한 타 진료 협진, 검사장비 등 취약

❖ 기출

- 항암 치료 후 원격전이, 근치적 치료 불가능함 알리고 호스피스 교육(12)
- HIV 확진 전달(11)
- CT 검사 후 위암 전달(09, 10)
- 유방 명을 발견 후 조직검사 결과 유방암 전달(09, 10)
- 아이 부모에게 백혈병 or 태아에게 다운 증후군 알리기

시행 관행 코멘트



아동 학대가 출제되었습니다. 이 경우 아이의 주산기력 및 사회력, 성장발달력도 추가 문진하면 좋을 것 같습니다. 그동안 주로 배우자 학대가 출제되긴 했지만, 아동 학대나 노인 학대가 나와도 진행할 수 있도록 연습이 필요해 보입니다.

비밀 보장을 2번 이상 해야 하는 경우가 있습니다. 서로 다른 멘트로 2개 정도 준비해 가시는 것이 좋겠습니다.

기존 ‘가정 폭력’과 ‘성 폭력’으로 나뉘어져 있던 항목이 합쳐졌습니다. 가정 폭력과 성 폭력 모두 환자와의 관계가 중요하며, 조심스러우면서도 지지적인 입장에서 면담을 진행하는 것이 중요하지만, 세부적인 내용에 대해서는 물어 보는 항목이 다르기 때문에 차이점을 잘 기억해 두세요.

가정 폭력의 경우 제시문에 가정 폭력이 의심되는 상황이라고 나오기 때문에 가정 폭력을 준비하고 들어갈 수 있지만, 환자는 **멍이나 골절, 수면장애를 주소로 내원하였다고 얘기**하기 때문에 초반에 **비밀 유지를 이야기하면서 라보를 쌓아야 폭력 사실을 얘기해 주고 진행이 가능합니다.**

가정 폭력의 종류에는 배우자 학대, 아동 학대, 노인 학대 등이 있지만 CPX 항목에서는 배우자 학대가 주로 출제됩니다. 환자에게 현재 폭력 이 외에도 **동반된 정신 질환이나 경제적인 어려움** 등에 공감해 주고 함께 치료할 수 있는 방향을 제시해 주는 것이 좋습니다. 경우에 따라 환자가 초반에 폭력에 대해 숨겨서 진행이 되지 않는 경우에는 **비밀 유지에 대해 두 번, 혹은 세 번까지 이야기해야 환자가 폭력 사실을 알려주는 경우도 있으므로** 참고하세요.

환자와의 관계가 잘 형성되고 나면 이후의 병력 청취나 교육은 크게 어렵지 않습니다. 중간중간 **진심을 담은 격려와 위로**를 하고, 환자가 적절한 대처를 할 수 있도록 **교육을 꼼꼼하게** 해주어야 합니다. 더 나아가 **폭력의 부당함을 환자가 인지**할 수 있도록 도와주고, 국가에서 제공하는 **보호소의 존재, 관련법 및 정책** 등을 소개해주어 환자가 현재 상황에 적절하게 대처할 수 있도록 도와주어야 합니다.

성 폭력 증례의 경우 **처음 환자에게 안전한 환경을** 인지시켜 주면서 안심시키고, 이후에 **진료 과정에 대해 언급하며, 동의서 작성과 비밀 보장**에 대해 설명하는 것이 좋습니다. 이후에 성 폭력 상황과 이전 **월경력에 대해 문진**으로 정보를 얻고, **P/E에서는 주로 증거 채취를 위한 과정**임을 잘 설명해야 합니다.

마지막으로 환자 교육에서는 **어떤 검사를 할 예정인지와 함께 재방문 시기**를 안내하고, **정신과적 치료**로 도움을 줄 수 있음을 알려주는 것을 잊지 말아야 합니다. 병력 청취하는 과정에서 환자를 **취조하듯이 질문하며 정보를 얻어내려고 하는 태도는 옳지 않습니다.** 의사로서 환자에게 성 폭력 당시의 상황을 물어보고 처치를 해야 하지만, 환자는 그 당시를 떠올리는 일이 굉장히 힘든 일입니다. 따라서 의사는 환자를 배려하는 태도로 진찰하는 것이 가장 중요합니다. 환자가 반응이 느릴 수도 있으나 **여유를 가지고 대답을 기다려줘야** 합니다.